

32-Influences sur l'oeil

C'est un lieu de grande information, à la fois vers l'unité motrice. Et on voit que la capsule de tenon, vous vous souvenez, cette capsule, elle est reliée finalement à l'ensemble du corps. Et finalement, l'élaboration aussi qui va se faire dans un programme neurosensoriel. Ça veut dire qu'il va intégrer toutes ces informations finalement sur un tonus, tu vois, un tonus postural. Ce tonus postural, c'est presque une chimie posturale. Ça veut dire que vous avez au niveau de votre hypothalamus, si tu veux, qui va intégrer beaucoup d'informations vis-à-vis du thalamus, vis-à-vis du pulvinar, vis-à-vis de tous ces noyaux, autour de ce système ventriculaire, par exemple. Il va intégrer des informations trophotropes ou ergotropes, on va dire. Donc ça veut dire qu'il va donner des informations de type sympathique, parasympathique, en fait. Donc en d'autres termes, vous allez avoir, au travers de toutes ces informations que vous recevez vers l'hypothalamus, même par les yeux, vous allez avoir une chimie posturale qui va s'installer depuis un plan cellulaire d'oxydoréduction, de guanine, adénosine, guanine, monophosphate, guanine, monophosphate, qui va intégrer des informations de type acido-basique, si tu veux, dans ton corps. Et l'hypothalamus, il va reprendre ces informations et il va te donner, en fonction du moment, la tonicité que tu dois avoir. Par exemple, tu peux avoir un mouvement de spirale droite vers la gauche ou gauche vers la droite, mais vers l'avant ou vers l'arrière, tu vois, qui sera plutôt ergotrope ou plutôt trophotrope. Ou plutôt, tu as perdu ton énergie, dépression, surpression, tu vois, ou les rêveurs. Et en fait, vous allez avoir toute une chimie posturale qui va s'intégrer dans un tonus avec différentes afférences qui vont se faire sur ton système cortical, visuel, efférence, pathway, donc les chemins visuels efférents, qui va toujours recorriger, ré-influencer continuellement l'information, donc tu vas être en continu en feedback positif ou négatif. Tu vas tout le temps rechercher, mais ça va s'intégrer dans des spirales spécifiques

qui vont te mettre, parfois, dans un schéma de déplacement de ton centre de gravité avec ouverture ou fermeture de tes sphincters. Donc, diarrhée, constipation, diarrhée mentale ou constipation mentale. C'est le même schéma. Avec des schémas spécifiques sur le plan sympathique ou parasympathique et tu vas retrouver des noyaux spécifiques au niveau même digestif qui sont tout ça en intégration avec ton tonus. Donc, tu vois comment l'œil déjà, en tant que, quand même, grande source d'information continue, va intégrer tous ces messages avec tous ces cortical, visuel, pathway, efférence ou afférente aussi, cette information sur ton système tonique avec un résultat postural spécifique qui est la meilleure adaptation possible que tu peux avoir dans le moment. Il n'y a pas de mauvaise position. Il n'y a que la meilleure réponse fonctionnelle du moment. Donc, faire confiance à ce que tu vois, mais parfois, aider le programme pour qu'il ne puisse pas tourner en boucle. Et c'est là où on doit avoir, je pense, le mot, le regard, le geste qui doit être libérateur. Et pour ça, on ne peut que le faire dans le bon temps et le bon espace, à condition aussi que tu aies la bonne image mentale, parce que tu dois retrouver des routes spécifiques et des énergies spécifiques, à la fois sur un plan électrique, pour reconnecter les schémas. Tout ça, ça va être véhiculé, n'oubliez pas, vers ce niveau du cortex géniculé qui va donc intégrer, faire le triage via la voie magno-cagno-parvo-cellulaire avec des informations qui vont venir de toute la périphérie, entre autres du système de PAPES, pour vous donner la juste information la plus possible, du moment, dans un schéma neurosensoriel spécifique. Tu dois comprendre le phénomène habitus. Et c'est là où tu as des cartographies de même afférence, tu vois, qui tournent, dans lesquelles, des fois, tu ne sais pas sortir, dans lesquelles, parfois, tu ne préfères pas sortir. Parce que ça te conforte dans le moment. Mais à un moment donné, ça passe aussi. C'est pour ça que la méditation va vous aider. Donc, ça veut dire que l'on voit ce que l'on veut.

Automatiquement, par ces schémas d'habitus, on va perdre une réalité. Ce programme peut recharger l'information qui est à vue. Donc, l'orbite, le crâne, parfois, il peut y avoir des micro-lésions que tu peux retrouver. Ces micro-lésions, sur le plan facial, au niveau de l'œil, peuvent aussi déjà changer l'orientation de l'œil vers différents programmes. Certains angles d'orientation, même mécaniques, comme les saccades d'adaptation, que tu vas tenter de faire. Rien que sur le plan myofacial, l'œil a une extrême importance dans sa conformation d'intégration de l'information neurosensorielle. C'est pour ça que ça va toucher, tu vois, ces différentes voies qui sont intégrées là-dedans. Voir comment tu veux voir. Avec toute l'information tectospinale ascendante, par exemple, qui va t'être intégrée sur le plan médulaire, qui revient de tous ces programmes de mémoire dans le tissu facial. C'est pour ça que le fascia, c'est un tissu qui est extrêmement intelligent, qui peut stocker de l'information. Qui peut stocker une mémoire, tu vois, avec certaines zones spécifiques, comme ça, qui peuvent être stockées. Et parfois, si tu es dans l'écoute au bon endroit, juste temps, juste espace, avec ta bonne cartographie, et avec le cadeau que tu offres à ton patient, c'est cette qualité de présence, et bien paf, tu peux avoir une libération. Donc toute cette représentation mentale, tout cet habitus que vous avez, comme une représentation mentale de l'événement. Comprendre que c'est influençable et influencé. Même votre propre tonus peut soutenir votre message visuel. Gouttière, et ici vous avez un tissu qui va subir un champ de détraction, ici, qui est un premier niveau d'information de votre ménage, mais qui, je vous rappelle, est quand même emballé autour de tout votre cerveau. Et qui vont aussi influencer tout ce qui se passe ici. j'ai toute une chaîne qui va jouer. Donc c'est toute cette relation durmérienne, méningée, qui s'intègre déjà dans l'œil. Ça veut dire que l'œil va regarder sa lésion, l'œil va être attiré facialement. C'est le phare de tous les facials. Ça veut dire que tout s'intègre à ce

niveau-là. Donc vous allez, vous allez dans le niveau préférentiel de votre système. L'œil ne sait pas vous tromper. Il est trop pur. L'œil, il a une pureté. Le photon, ici, qui aussi s'intègre comme source lumineuse. Ce n'est pas que juste une transformation dans un changement purement électrique. Ça peut être considéré d'un autre côté comme une énergie physique pure, elle-même composée d'un mouvement de particules. Ou presque de systèmes ondulatoires. Tu comprends ? Cette particule lumineuse, on peut la retrouver dans une libération d'énergie. Ça veut dire que cette énergie est dépendante de la longueur d'onde et de la fréquence. Donc vitesse, Δ . Donc si la fréquence augmente, la longueur d'onde diminue. Donc augmentation d'énergie. Vous comprenez ça ? Si la vitesse diminue, si la fréquence augmente, la longueur d'onde va diminuer. Mais l'énergie lumineuse va être stockée. Et ces énergies sont très importantes parce qu'on va les subir continuellement. Sans spécialement les voir. Ça veut dire qu'à partir d'un champ, par exemple thermique pur, qui sont captés sur un plan rétinien, ça produit une mobilisation fluide. Et là, on voit qu'au niveau de la rétine, au niveau de ces petits disques, on a découvert des petites flagelles qui sont activées au niveau des cônes et des bâtonnets. Ces flagelles peuvent bouger vers la lumière. Elles ne sont pas que des capteurs d'informations, mais aussi et surtout des capteurs d'énergie pure. C'est là où on peut émettre une énergie lumineuse avec les yeux, où on peut recevoir de l'énergie lumineuse avec les yeux. La lésion sympathique autonome, est la cause la plus fréquente au niveau de la fatigue physique. Cette lésion va donner en fait une mydriase. Et donc ce sont surtout les bâtonnets qui subissent cette information. Ça veut dire qu'ils sont de plus en plus agités, ce qui va épuiser finalement le système sympathique autonome du corps. Donc souvent, c'est une information lumineuse qui vous épuise parfois. Donc trop d'écrans par exemple, ça va travailler là-dessus. Par exemple, une lésion

surrénale, avec une irritation du splanchnique, avec une irritation ascendante du ganglion cervical supérieur et du plexus carotidien, avec lequel tout le système olfactif, le réflexe pupulaire est perturbé. Donc tu vois comment le stress énergétique peut aussi te dégrader. Donc attention par rapport à ces informations-là. C'est là où c'est la juste information lumineuse. C'est pour ça que l'aura se trouve dans cette zone B au départ. Qui est un plan lumineux, tu vois. Si tu es bien à la place dans ta vie, tu es lumineux. C'est ça le corps de lumière. ils ne sont pas dans leur place, ils sont éteints. où ils doivent être. J'ai un embryon qui est comme ceci, avec mon cœur, la vésicule, le diaphragme qui sera ici. Ce lien important ici. c'est qu'on doit retrouver une paix en nous. Tu reçois une possibilité de sagesse, mais tu dois la travailler. Par contre, le cadeau qu'on reçoit, on reçoit en nous, et ça, il est caché comme une pépite. On reçoit l'amour. Cette faculté d'amour. Cette faculté d'aimer. Qu'on reçoit déjà par sa maman. Ou par son entourage. Et l'embryon, il fait un mouvement de flexion. Il fait ça. Il fait ce grand mouvement de flexion. Et tout revient vers le cœur. Ça veut dire que si tu arrives à ramener ta sagesse et la paix vers le cœur, il y a quelque chose qui va émerger autour de toi, une énergie très très belle, qui est l'énergie que j'appellerais une énergie de dévouement. La vraie solidarité. Tu portes le message. Et là, tu émanes cette lumière du cœur. Tu comprends ? L'œil va subir tout ce programme énergétique, tout ce programme énergétique pur, et tout ce programme d'interprétation qu'il va faire. Avec un système qui va s'intégrer sous forme de programme, ou même d'abord de pré-programme. Tu vas te pré-programmer, Petit à petit, ça nous fait rentrer dans un plan finalement électrique du système, électromagnétique, lumineux du cœur. Ça, c'est la grande danse des électrons. Ça, c'est aussi quand même une chose intéressante, c'est ce grand fulcrum mobile. Ça veut dire que le cœur est dans le mésoderme fluidique, qui devient le fulcrum mobile du corps et du

cerveau. Pour l'œil, c'est le fulcrum mobile de l'ectoderme qui va se retrouver. C'est un fulcrum qui est très électrique, avec un environnement soit libre, soit fixé. Il y a aussi ce nouveau volumie. Le cœur, il émet un énorme champ électromagnétique, parce qu'il a une polarité très puissante. Ça veut dire que l'œil lui-même, deux grands courants ici. Le cœur gauche et le cœur droit. Vous avez l'œil droit et l'œil gauche. La main droite, la main gauche. Vous avez une volumie avec tout un système où vous voyez que le système cavale, cave, est déplacé sur la gauche, et le système matériel est déplacé légèrement sur la droite. Ça veut dire que j'ai deux grands courants. Ça fait comme ça. Regardez bien. Vous comprenez ? Ça, ça monte vers le cœur, et ça, ça descend sur le cœur. Inverse au niveau de l'œil. Et donc, je vais avoir deux yeux qui vont recevoir une volumie différente. Si on voit l'anatomie ici, le parcours qui va se faire sera différent, aussi bien au niveau jugularis que même des confluent en dessous. qui va s'intégrer avec un artériel outflow descendant et une venous inflow remontant. Mais l'inverse au niveau du cerveau. Ça veut dire qu'on va retrouver ce schéma artériel, tu vois, par exemple ici, avec le système aortique, le tronc brachio ici, et puis vous avez la carotide interna, qui va donner tout un processus ici important, et un autre chemin, quatre portes d'entrée dans ton cerveau, finalement, tu vois, qui vont arriver ici, qui vont donc vasculariser pour les grosses deux tiers antérieures et en arrière, un tiers postérieur, par ce système-là, avec des petites connexions, avec le système qu'on appelle l'artère, par exemple, vertébrale gauche et droite, qui va donner le système basilaire, qui va donner la cérébrale postérieure, tu vois, et il y a une petite sauvegarde pour un peu, en cas d'une sténose ou quoi que ce soit, quand même, rééquilibrer les processus. Il y a une différence importante, finalement, sur un plan vasculaire, tu vois, entre l'œil gauche et l'œil droit. Le droit sera plutôt lié à des stases veineuses hépatiques. Par contre, l'œil gauche, il va être plutôt en relation avec une

hyperpression artérielle, donc deux courants différents qui seront en fait, simplement, déjà des positions anatomiques qui vont donner des interférences spécifiques sur le cortex visuel, rien que sur le plan artériovéneux de l'œil. On retrouve ça au niveau testiculaire, par exemple, où vous avez, par exemple, la veine spermatique gauche et droite qui ne vont pas se jeter dans le même processus. Il y en a une qui va se jeter, la gauche va se jeter au niveau de l'artère rénale, et donc, il peut y avoir une congestion rénale gauche qui peut se manifester sur des varicocèles gauches, C'est le même processus de retour différentiel au niveau de la droite, où ça va se manifester direct, dans le système cavale, ascensionnel, si tu veux. Très souvent, tous les problèmes gynécologiques du côté gauche doivent être traités sur le plan rénal et sur le plan vasculaire rénal gauche. Ça, c'est ce passage avec ce qui est asthma, les artères, avec, entre autres, ce passage important entre la carotide et le nerf optique, qui donne une information pulsatile. L'œil, il sera dépendant du système carotidien. Donc, tu vois, une espèce de passage avec un niveau important qui se trouve de nouveau sur cette glande hypophysaire. C'est pas pour rien que le système vasculaire se met tout proche de certains réseaux, tu vois, pour donner des informations. Pourquoi c'est une des glandes les plus importantes ? Parce qu'elle reçoit toutes les informations oculaires, par déjà rien que le système artériovéneux, par rien que déjà les chiasmas, de type facial, de type neurocrâne, viscérocrâne. Donc, cette glande, vraiment, elle est informée complètement en continu de ce qui se passe. C'est pour ça qu'elle va donner avec l'hypothalamus, tiens, tac, OK, on va te donner des schémas d'adaptation continus, auditifs pathway, tes kinétiques pathway qui vont s'informer dans ton schéma. Mais en même temps, il y a une latéralité qui sera donnée continuellement par le développement embryologique sur le plan lax nodal, avec le mouvement de latéralité, où on va retrouver une information du cœur droit, une contre-rotation

au niveau médiastinal à gauche, une contre-rotation à gauche, ici, avec finalement un œil qui va s'adapter dans une latéralité gauche. Donc je pars, ici, comme ça, et là, je vais contrebalancer, mon cœur va faire ça, tout mon médiastin, ma main à gauche, et mon œil, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit faire une correction droite, donc j'ai à la fois une spirale, comme ceci, tu vois, dans ma verticalité, pour mon horizontalité. Donc je vais rechercher en continuellement cette adaptation par rapport à mon système médiastinal. Donc un déséquilibre oculaire peut être une déstabilisation médiastinale. Tout ça, c'est dans une synchronicité. Il y a certains réflexes qui sont intéressants. Le réflexe, par exemple, fronto-orbitaire, si je tape ici, tac, il y a toujours la fermeture palpébrale qui va se faire. Il y a le réflexe oculocéphalogire, donc le mouvement des rééquilibres toujours au niveau des yeux. Et puis il y a un réflexe qui est intéressant, le réflexe auriculo-cardiaque. Une pression légère au niveau des yeux peut rééquilibrer des problèmes de fibrillation ou de tachycardie supraventriculaire, je pense. En fait, un jour, il y a eu un enfant qui est arrivé dans ce phénomène tachycardique, dans cette déstabilisation cardiaque, et en fait, il a simplement appuyé sur les globes oculaires. Pour assurer une régulation de l'activité tonique, posturale, surtout quand on est debout, il y a un œil qui sera postural, mais vous avez aussi un œil qui est dominant. Ce n'est pas toujours le même. Ton œil dominant n'est pas spécialement ton œil postural. Parfois oui, parfois non. Donc ça, c'est les fameuses spirales qu'on va retrouver comme ceci. Et l'œil va faire un mouvement comme ceci. C'est ces deux mondes spiralés de l'orbite et de l'œil qui vont se croiser. Et ça va donner un rééquilibrage. C'est justement aussi une spirale en profondeur et qui va, par rapport à l'œil, donner les zones presque visuelles. Avec des axes sur le plan spiralé, on va voir que l'axe oculaire va se retrouver sur la zone pratiquement oculaire. Ça, c'est d'autres axes ici. Et justement, si on voit la partie supérieure et la

partie inférieure, on voit comment tout ça va se croiser de nouveau dans le système entre Bregma et l'hypophyse, l'ioïde, ces deux, ces trois. C'est comme s'il y avait quand même une géométrie spécifique d'organisation qui s'était installée. Encore un autre niveau d'information. On voit l'organisation ici, faciale, orbitaire. C'est un axe dans lequel on a une représentation environ de 90 degrés. Un axe visuel, 45 degrés. Avec ton axe visuel pur ici, avec seulement un changement de possibilité de 23 degrés. Donc tu vois l'angle possible dans un œil fixé. Ça veut dire que l'œil a une fourchette de liberté, finalement, d'intégration lumineuse neurosensorielle pure de 23 degrés. Ce chiffre 23 se retrouve en pas mal de circonstances. L'inclinaison de l'équilibre de la Terre par rapport au Soleil et par rapport à la Lune, c'est 23 degrés. L'inclinaison au niveau de ton système vestibulaire, à un moment donné, ça va faire un angle de 23 degrés. Le cœur va s'incliner à 23 degrés. Tu vas répondre à des informations presque externes vers des informations internes. Et alors, on a encore des axes un peu plus spécifiques qui seront intéressants aussi à étudier. On voit ici, par exemple, on a un axe de l'œil vers le niveau pétreux ou bien un axe purement orbitaire pyramidal. C'est des lésions qui vont se retrouver. On a ces axes purement ici avec l'information descendante, l'information ascendante. Mais ici, on voit par exemple un axe qui est intéressant, c'est cet axe pétreux. Et là, vous avez une relation déjà Et je vous rappelle que tout ce côté mastoïdien ici, c'est lui justement qui contient tout le système de l'oreille interne. avec la mastoïde. Ça veut dire que l'œil, par rapport à ça, si j'ai déjà une déstabilisation entre cet axe-là et par rapport à l'œil, je vais pouvoir avoir une déstabilisation dans mon système d'équilibre. Et donc je vais créer des saccades spécifiques, soit par ce qu'on appelle des lésions spécifiques de l'œil, mais aussi des mémoires qui sont enregistrées. Parce que parfois, tu as beau corriger comme ça des vertiges, tu vois, mais il y a une

mémoire qui est intégrée dans l'os, ou qui est intégrée dans un schéma purement électrique, d'ordre axial. Avec ici des lignes fonctionnelles craniométriques de santé, tu vois, qui vont se retrouver, avec au milieu ce fameux diaphragme stellé, qui est un fucrum puissant sur la ligne médiane, avec le canal de cloquet, qui va s'intégrer avec le nerf optique. Et on voit ici tout le système avec les sphénoïdes antérieurs et postérieurs, avec les attaches de la tente dysclinique. Et on voit ici le cervelet. Donc le cervelet, de nouveau, sera très important dans son rééquilibrage, sur un plan fonctionnel. Donc je vais simplement prendre ce cervelet et le rééquilibrer par rapport à l'espace. Je vous rappelle qu'il fait partie de la fonction, déjà, de la flexion pontique primitive, avec la rencontre du feuillet supérieur et inférieur, et l'intégration future de tout ce système pontique, donc de toute l'intégration du cervelet, qui fait un mouvement à la fois comme ceci, mais comme ceci. C'est le même temps que la tente du cervelet s'est mise en place, donc elle contient toute l'information de cette mise en place. Donc le fait de rééquilibrer une tente du cervelet, depuis Astéryon, qui est important, qui est en relation aussi avec l'Astragal. Astragal, Astéryon, ce sont des choses, chaque pas libère Astéryon. Donc ça veut dire que des problèmes là-haut peuvent être des problèmes du talon. On va aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc il y a aussi une ligne fonctionnelle transversale, oculaire antérieure, tu vois, qui est aussi important, et une ligne vestibulo-vestibulaire, qui est en rapport avec cette ligne ici. C'est pour ça qu'on a les recherches de saccades aussi, ou bien les recherches de rééquilibre dans le plan antéropostérieur, ou bien de latéralité. Je vous ai dit, quand je travaille, je fais attention de regarder l'œil, de regarder le mouvement oculaire, et de regarder un peu comment l'œil va se positionner dans l'espace, et comment parfois l'œil il est fixé comme ça. Donc parfois on peut voir que des gens sont fixés sur un schéma, et en fait ça s'appelle les aires. Par

exemple, si on va prendre l'œil droit d'abord, si vous regardez en haut et à droite, vous êtes dans une visualisation de création. Tandis que si vous regardez à l'horizontale, l'œil sera en rapport, tu vois ces petits mouvements oculaires, là vous allez avoir ce qu'on appelle l'audition créée. Tandis qu'en bas, à droite, vous allez avoir tout ce qu'on appelle le côté kinesthésique, sensation, Vous allez avoir tout ce qu'on appelle le côté kinesthésique, sensation, sensation de ressenti interne ou sensation de ressenti externe. sensation de ressenti interne ou sensation de ressenti externe. En haut à gauche, c'est une mémoire. Et en bas et à gauche, c'est que vous êtes tout le temps dans le dialogue intérieur. Je fais tout un travail de libération à ce niveau-là, et puis je fais un travail de recherche au niveau du globe oculaire. Je regarde son mouvement oculaire préférentiel. Et là il va m'orienter vers des niveaux visuels, auditifs, kinesthésiques. interne, kinesthésiste, externe. Parfois vous avez pu être dérangé dans votre vie par un par un bruit externe. Vous avez tout votre schéma postural qui est fixé dessus. Les gens qui ont subi un traumatisme par exemple lors des attentats sont bloqués sur des schémas très profonds. Là-dedans. Ils sont bloqués parfois et donc il faut les décoder parfois, il faut les aider à sortir de ces schémas. À gauche au milieu mémoire auditive, en bas dialogue continue à l'intérieur.